



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
MANAJEMEN RISIKO
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
SEMESTER I
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KINERJA MANAJEMEN RISIKO

RS PRIMA HUSADA MALANG

SEMESTER I TAHUN 2026

Laporan Kinerja Manajemen Risiko Rumah Sakit Prima Husada Malang disusun sebagai hasil evaluasi pelaksanaan program manajemen risiko, khususnya terhadap efektivitas pengendalian dan mitigasi risiko di tingkat rumah sakit. Laporan ini bertujuan untuk menilai keberhasilan upaya pengelolaan risiko dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pemenuhan standar akreditasi STARKES

Disusun Oleh:

Komite PMKP RS Prima Husada Malang

Malang, 07 Juli 2026

Telah Disetujui Oleh:

Direktur PT Disa Prima Medika



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kinerja Manajemen Risiko

RS Prima Husada Malang

Laporan Manajemen risiko adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, sehingga dampaknya terhadap organisasi dapat diminimalkan.

Disusun oleh:

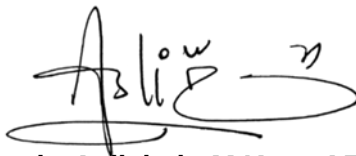
Komite PMKP RS Prima Husada Malang



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Disetujui oleh:

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko Semester I Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, serta meminimalkan risiko yang berpotensi menimbulkan cedera pada pasien, staf, maupun pihak lain yang berada di lingkungan rumah sakit.

Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keselamatan pasien melalui identifikasi dan pengendalian berbagai risiko strategis maupun operasional yang dapat memengaruhi mutu pelayanan. Pengelolaan risiko tersebut mencakup seluruh area rumah sakit, baik manajerial, administratif, maupun pelayanan klinis. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang efektif untuk memastikan risiko dapat dikendalikan dan diminimalkan secara berkelanjutan. Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran mutu rumah sakit. Melalui pelaksanaan program manajemen risiko yang terstruktur, diharapkan rumah sakit mampu menerapkan pendekatan yang proaktif dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai keseimbangan yang optimal antara risiko, manfaat, dan biaya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program serta penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko Semester I Tahun 2026 ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Penyusun

Komite PMKP RS Prima Husada Malang

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :	8
2.3 Motto	8
2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	8
2.5 SOTK Komite PMKP	8
BAB III HASIL KEGIATAN	9
3.1 Profil Risiko	9
3.2 Rencana Penanganan Risiko	9
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	12
4.1 Pemantauan dan Pengendalian Risiko	12
4.2 Hasil Pemantauan	14
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai proses pelayanan klinis maupun nonklinis yang berpotensi menimbulkan risiko. Risiko tersebut dapat berdampak terhadap keselamatan pasien, keselamatan staf, keberlangsungan operasional, kondisi keuangan, maupun reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Penerapan manajemen risiko yang efektif memungkinkan rumah sakit untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi, mengurangi dampak yang ditimbulkan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko juga menjadi salah satu elemen penting dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit sesuai Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan (STARKES).

Selama Semester I Tahun 2026, Rumah Sakit Prima Husada Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan prioritas risiko, pelaksanaan mitigasi, monitoring, serta evaluasi terhadap efektivitas pengendalian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, ditetapkan beberapa risiko prioritas yang memerlukan perhatian dan pengendalian secara berkelanjutan karena memiliki tingkat dampak dan kemungkinan kejadian yang tinggi terhadap pelayanan rumah sakit.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program manajemen risiko, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas upaya mitigasi yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pengendalian risiko, menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan pada periode berikutnya, serta mendukung tercapainya sasaran mutu, keselamatan pasien, dan tujuan strategis Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 1.2.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 1.2.3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.
- 1.2.4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- 1.2.5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Manajemen Risiko Semester I Tahun 2026 dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program manajemen risiko di Rumah Sakit Prima Husada Malang, khususnya dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang berpotensi mempengaruhi mutu pelayanan, keselamatan pasien, keselamatan staf, serta pencapaian tujuan organisasi rumah sakit.

1.3.2 Tujuan

- a. Mengetahui efektivitas pelaksanaan program manajemen risiko yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2026.
- b. Mengevaluasi keberhasilan upaya mitigasi dan pengendalian terhadap risiko-risiko prioritas rumah sakit.
- c. Mengidentifikasi risiko yang masih memerlukan tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan.
- d. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan strategi pengelolaan risiko pada periode berikutnya.
- e. Mendukung pencapaian sasaran mutu, keselamatan pasien, keselamatan staf, serta keberlangsungan pelayanan rumah sakit.
- f. Memenuhi ketentuan monitoring dan evaluasi program manajemen risiko sesuai standar akreditasi rumah sakit dan kebijakan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

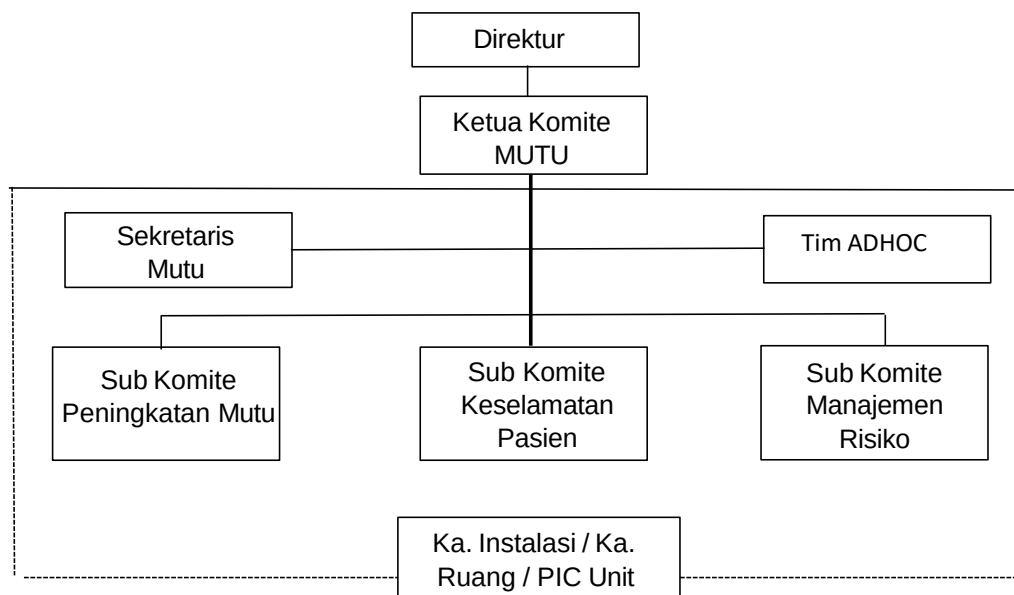
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Komite PMKP



BAB III HASIL KEGIATAN

3.1 Profil Risiko

No	KATEGORI RISIKO (KLINIS/ K3/ KEUANGAN/ OPERASIONAL/ REPUTASI)	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISA RISIKO INHERENT
		PERNYATAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT (D & P)	SKOR	PERINGKAT RISIKO
1	Non Klinis	Jika petugas tidak melakukan pemeliharaan alat, maka berisiko alat rusak, sehingga pelayanan dapat terganggu	4	5	45	20	1
2	Klinis	Jika terjadi miskomunikasi antar tenaga kesehatan maka dapat menyebabkan kesalahan terapi dan tindakan yang tidak sesuai pada pasien	4	5	45	20	2
3	Non Klinis	Jika downtime sistem berisiko pelayanan terhambat dan berakibat tidak dilayaninya pasien	4	4	44	16	3
4	Non Klinis	Jika sistem e-klaim terganggu maka proses klaim tertunda dan berdampak pada keuangan rumah sakit	5	3	53	15	4
5	Klinis	Jika tidak teliti, berisiko salah input e-resep dan menimbulkan cedera	5	3	53	15	5

3.2 Rencana Penanganan Risiko

No	Kegiatan	Sasaran	Risiko (Prioritas/Sangat Tinggi)	Alternatif Teknik Penanganan Risiko		Pengendalian Yang Sudah Ada			Rencana Pengendalian			Pemilik Risiko	PJ TL Pengendalian
				Opsi Teknik Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Efektif/Kurang Efektif	Pengendalian Yang Harus Ada	Kegiatan	Waktu	Jenis (Detektif (D), Preventif (P), Korektif (K))		
1	Pengelolaan Pemeliharaan Alat Medis	Seluruh alat medis berfungsi optimal	Kerusakan alat akibat tidak dilakukan pemeliharaan	Mitigasi	Monitoring pelaksanaan preventive maintenance dan kalibrasi alat	SPO Pemeliharaan Alat	Kurang Efektif	Checklist pemeliharaan, monitoring kepatuhan jadwal, evaluasi bulanan alat	Audit kepatuhan pemeliharaan alat dan monitoring preventive maintenance	Bulanan	Preventif	IPSRs	Karu IPSRS
2	Peningkatan Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan	Seluruh tenaga kesehatan	Kesalahan komunikasi klinis yang menyebabkan kesalahan terapi/tindakan	Mitigasi	Pelatihan komunikasi efektif, supervisi handover, audit SBAR dan briefing-debriefing	SBAR, TulBaKon, handover terstruktur	Kurang Efektif	Audit kepatuhan SBAR, checklist handover, supervisi rutin	Audit komunikasi efektif dan pelatihan refreshment SBAR	Triwulan	Preventif	IGD	Kepala IGD dan Komite PMKP
3	Penguatan Sistem Teknologi Informasi Rumah Sakit	Sistem informasi rumah sakit	Downtime server atau sistem lambat	Mitigasi	Maintenance server, backup data, monitoring jaringan,	Pemeliharaan server berkala	Kurang Efektif	Server backup, monitoring real time, evaluasi kapasitas server	Monitoring performa server dan simulasi downtime	Bulanan	Preventif	IT	Kepala IT

					simulasi downtime								
4	Pengendalian Risiko Gangguan E-Klaim BPJS	Proses klaim BPJS	Kegagalan proses klaim yang menyebabkan klaim tertunda	Berbagi Risiko	Monitoring sistem, koordinasi dengan BPJS dan IT, backup proses manual	Monitoring IT	Kurang Efektif	Audit klaim	Audit klaim BPJS	Bulanan	Detektif	Asuransi Center	Karu Asuransi Center
5	Peningkatan Keamanan Proses E-Resep	Proses peresepan elektronik	Kesalahan input e-resep yang berpotensi menyebabkan cedera pasien	Mitigasi	Validasi resep oleh apoteker, double check obat, pelatihan penggunaan e-resep dan pemanfaatan sistem alert	SPO Penulisan dan Input Resep	Kurang Efektif	Audit resep elektronik, penguatan clinical decision support dan double verification	Audit kepatuhan e-resep dan monitoring medication error	Bulanan	Preventif	Farma si	Kains Farmasi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Pemantauan dan Pengendalian Risiko

- 1) Kegiatan: Pengelolaan Pemeliharaan Alat Medis
Sasaran kegiatan: Seluruh alat medis berfungsi optimal

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Kerusakan alat akibat tidak dilakukan pemeliharaan	Pelaksanaan preventive maintenance dan monitoring kepatuhan jadwal pemeliharaan alat	Preventive maintenance telah dilaksanakan sesuai jadwal pada sebagian besar alat	Upaya preventive maintenance ke alat medis belum dilakukan menyeluruh karena keterbatasan SDM	Peningkatan monitoring dan penggunaan checklist pemeliharaan elektronik	Bulanan	Bulanan	Karu IPSRS

- 2) Kegiatan: Peningkatan Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan
Sasaran kegiatan: Seluruh tenaga kesehatan di IGD

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Kesalahan komunikasi klinis	Implementasi SBAR, supervisi handover, audit komunikasi efektif	Format SBAR telah diterapkan dalam proses handover antar tenaga kesehatan	Masih ditemukan risiko ketidaksesuaian informasi akibat pengisian SBAR yang tidak diperbarui atau penggunaan data sebelumnya tanpa verifikasi ulang	Penguatan verifikasi identitas pasien sebelum handover, serta edukasi ulang komunikasi efektif	Triwulan	Triwulan	Karu IGD/Komite PMKP

- 3) Kegiatan: Penguatan Sistem Teknologi Informasi Rumah Sakit
Sasaran kegiatan: Sistem informasi rumah sakit

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Downtime server atau sistem lambat	Maintenance server, backup data dan monitoring jaringan	Maintenance server, backup data, dan monitoring jaringan telah dilakukan secara berkala	Belum optimalnya evaluasi kapasitas penyimpanan dan kesiapan sistem dalam menghadapi peningkatan beban penggunaan	Melakukan evaluasi kapasitas penyimpanan, optimasi sistem, serta penguatan koordinasi dengan vendor apabila terjadi gangguan sistem	Bulanan	Bulanan	Kepala IT

- 4) Kegiatan: Pengendalian Risiko Gangguan E-Klaim BPJS
 Sasaran kegiatan: Proses klaim BPJS

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Kegagalan proses e-klaim BPJS	Monitoring sistem dan koordinasi dengan BPJS serta IT	Monitoring dilakukan setiap hari dan gangguan telah ditindaklanjuti	Gangguan bridging masih terjadi pada waktu tertentu	Penguatan koordinasi dengan IT	Bulanan	Bulanan	Kepala Asuransi Center

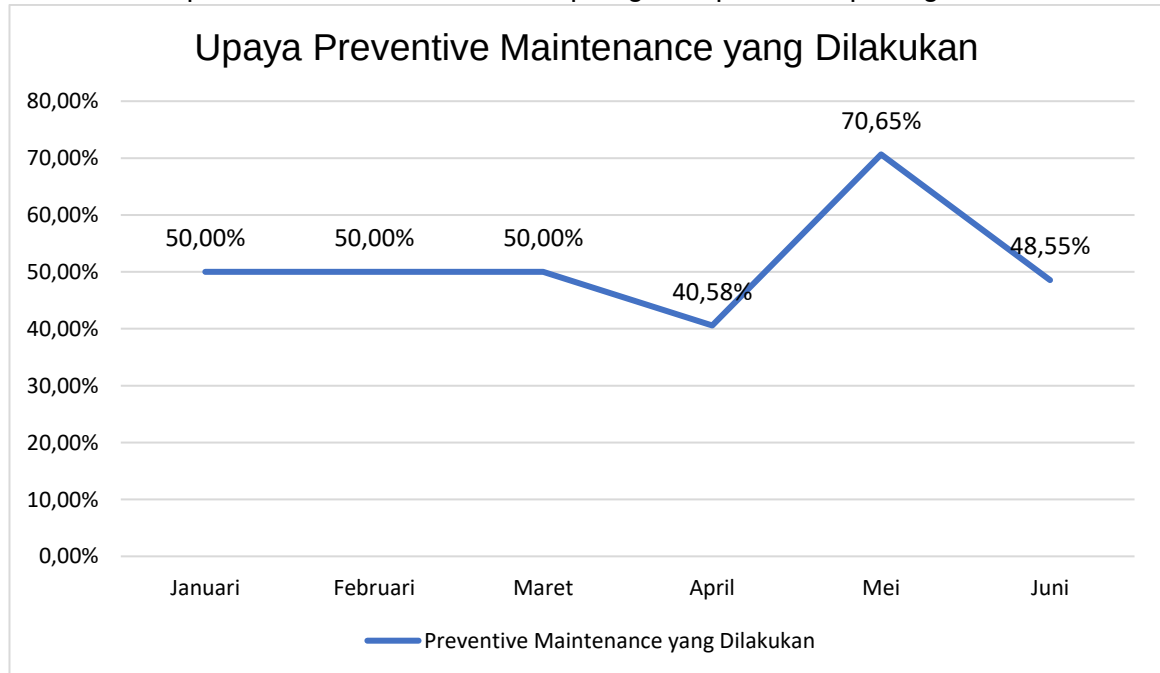
- 5) Kegiatan: Peningkatan Keamanan Proses E-Resep
 Sasaran kegiatan: Proses persepsan elektronik

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	Kesalahan input e-resep	Validasi resep oleh apoteker, double check dan monitoring kepatuhan e-resep	Validasi resep dan double check telah dilaksanakan	Belum seluruh fitur alert pada sistem e-resep berjalan optimal	Optimalisasi sistem alert dan audit kepatuhan e-resep	Bulanan	Bulanan	Kepala Instalasi Farmasi

4.2 Hasil Pemantauan

1) Pengelolaan Pemeliharaan Alat Medis

Pelaksanaan preventive maintenance oleh petugas dapat dilihat pada grafik berikut.



Analisis:

Berdasarkan grafik pelaksanaan preventive maintenance alat pada Semester I Tahun 2026, terlihat bahwa capaian pemeliharaan alat masih mengalami fluktuasi setiap bulan. Pada bulan Januari sampai dengan Maret, pelaksanaan preventive maintenance berada pada angka 50%. Pada bulan April terjadi penurunan menjadi 40,58%, kemudian meningkat pada bulan Mei menjadi 70,65%, namun kembali mengalami penurunan pada bulan Juni menjadi 48,55%.

Peningkatan capaian pada bulan Mei menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemeliharaan alat, namun penurunan kembali pada bulan Juni menunjukkan bahwa pelaksanaan preventive maintenance belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko kerusakan alat akibat tidak terlaksananya pemeliharaan secara optimal masih perlu diperkuat.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya capaian preventive maintenance antara lain belum optimalnya monitoring jadwal pemeliharaan, keterbatasan waktu petugas dalam pelaksanaan maintenance, serta koordinasi antara IPSRS dengan unit pengguna alat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa penguatan monitoring, evaluasi kepatuhan pelaksanaan pemeliharaan, serta peningkatan koordinasi agar seluruh alat mendapatkan pemeliharaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tabel PDSA

Problem	Pelaksanaan preventive maintenance alat belum optimal dan belum konsisten sesuai jadwal. Berdasarkan monitoring Semester I Tahun 2026, capaian preventive maintenance mengalami fluktuasi dengan capaian terendah pada bulan April sebesar 40,58% dan Juni sebesar 48,55%. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kerusakan alat yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan rumah sakit.
Plan	1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan preventive maintenance yang belum mencapai target.

	- Menyusun monitoring jadwal preventive maintenance secara berkala. - Meningkatkan koordinasi antara IPSRS dengan unit pengguna alat terkait kesiapan alat untuk dilakukan pemeliharaan. - Menetapkan prioritas pemeliharaan terhadap alat dengan risiko tinggi terhadap pelayanan.
Do	- Melaksanakan monitoring pelaksanaan preventive maintenance setiap bulan. - Melakukan koordinasi dengan unit terkait sebelum jadwal pemeliharaan. - Melakukan pencatatan hasil pemeliharaan dan kendala yang ditemukan. - Melakukan tindak lanjut terhadap alat yang belum dilakukan pemeliharaan.
Study	Melakukan evaluasi capaian preventive maintenance berdasarkan laporan pelaksanaan pemeliharaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan capaian pada bulan Mei sebesar 70,65%, namun capaian belum stabil karena kembali menurun pada bulan Juni menjadi 48,55%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan monitoring dan kepatuhan terhadap jadwal pemeliharaan.
Action	- Melanjutkan monitoring preventive maintenance secara rutin. - Melakukan evaluasi hambatan pelaksanaan pemeliharaan setiap bulan. - Meningkatkan kepatuhan unit terkait dalam menyediakan alat sesuai jadwal maintenance. - Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem monitoring pemeliharaan alat.

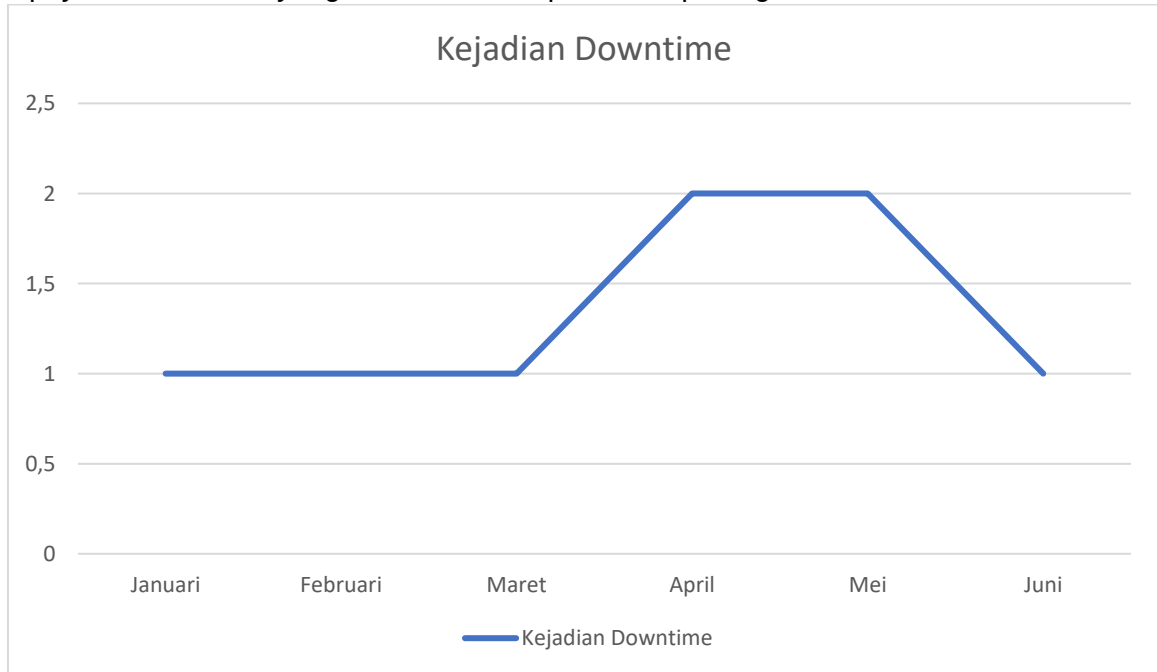
- 2) Peningkatan Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan di IGD
Kesalahan komunikasi klinis yang terjadi di IGD pada Bulan Januari-Juni Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Berdasarkan hasil monitoring, selama Bulan Januari sampai Juni ditemukan 2 kejadian IKP pada bulan April terkait ketidaksesuaian pengisian dokumentasi SBAR akibat

penggunaan informasi sebelumnya tanpa verifikasi ulang. Kejadian ini menunjukkan bahwa risiko kegagalan komunikasi klinis masih perlu dikendalikan, khususnya pada aspek ketepatan dokumentasi dan verifikasi informasi pasien.

- 3) Penguatan Sistem Teknologi Informasi Rumah Sakit
Upaya maintenance yang dilakukan IT dapat dilihat pada grafik berikut.



Analisis:

Berdasarkan data kejadian downtime periode Januari–Juni 2026, terdapat total 8 kejadian downtime dengan distribusi kejadian yang relatif fluktuatif setiap bulan. Kejadian downtime tercatat sebanyak 1 kali pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Juni, serta meningkat menjadi 2 kali pada bulan April dan Mei. Peningkatan kejadian pada bulan April dan Mei perlu menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mengidentifikasi penyebab utama, baik yang berasal dari faktor sistem, perangkat, jaringan, maupun sumber daya manusia.

Meskipun kejadian downtime belum menunjukkan pola penurunan yang konsisten, pemantauan dan tindak lanjut tetap perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya gangguan yang dapat berdampak pada kontinuitas pelayanan, terutama pada proses yang bergantung pada sistem informasi rumah sakit. Upaya perbaikan dilakukan melalui pencatatan setiap kejadian downtime, analisis akar masalah, evaluasi keandalan sistem, serta penguatan prosedur penanganan downtime agar pelayanan tetap berjalan secara optimal.

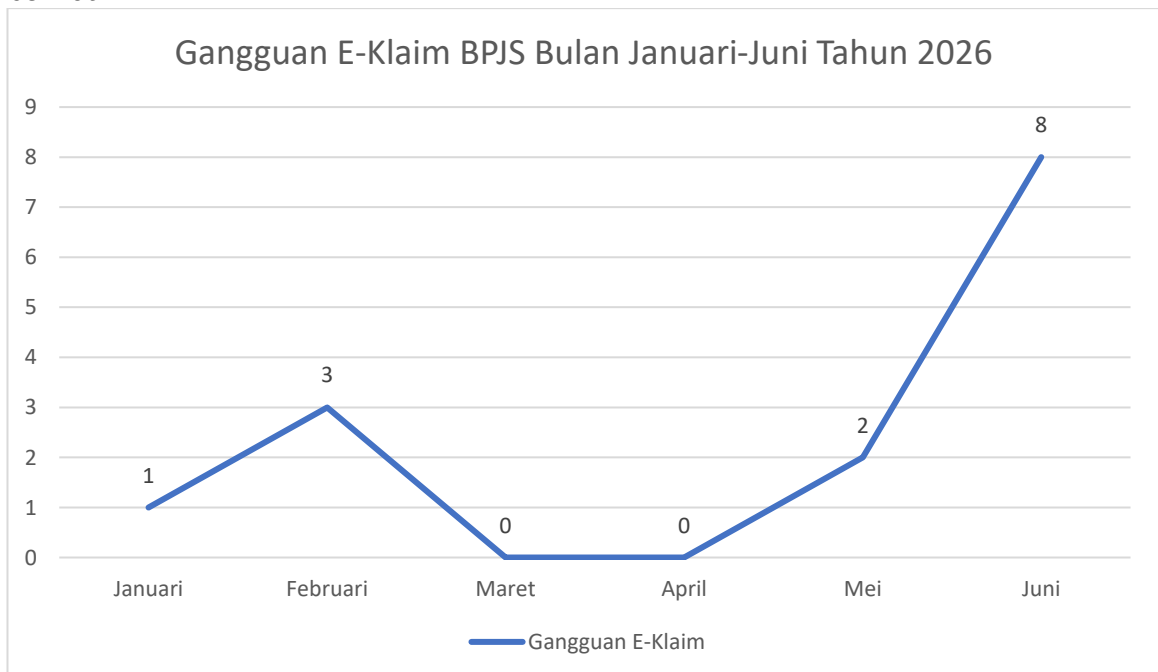
Tabel PDSA

Problem	Terdapat kejadian downtime sistem sebanyak 8 kali selama periode Januari–Juni 2026, dengan peningkatan kejadian pada bulan April dan Mei masing-masing sebanyak 2 kali. Downtime berpotensi menghambat proses pelayanan yang bergantung pada sistem informasi rumah sakit, sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dan upaya pencegahan agar kejadian tidak berulang.
---------	--

Plan	Melakukan identifikasi dan analisis penyebab kejadian downtime melalui evaluasi setiap laporan gangguan, melakukan pemetaan sumber masalah (sistem, jaringan, perangkat, maupun faktor pengguna), meningkatkan koordinasi antara unit pengguna dengan Instalasi Teknologi Informasi, serta menyusun rencana pencegahan dan perbaikan untuk meminimalkan kejadian downtime.
Do	Melaksanakan pencatatan setiap kejadian downtime, melakukan perbaikan sistem sesuai penyebab yang ditemukan, melakukan pengecekan dan pemeliharaan perangkat pendukung sistem secara berkala, serta melakukan sosialisasi alur pelaporan dan penanganan downtime kepada unit terkait.
Study	Melakukan monitoring jumlah kejadian downtime dan mengevaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan, kejadian downtime masih terjadi setiap bulan dengan frekuensi tertinggi pada April dan Mei, sehingga diperlukan penguatan upaya preventif dan evaluasi berkelanjutan terhadap keandalan sistem.
Action	Melanjutkan monitoring kejadian downtime secara berkala, melakukan evaluasi akar masalah pada setiap kejadian, meningkatkan preventive maintenance sistem dan infrastruktur pendukung, serta melakukan penyempurnaan prosedur penanganan downtime agar pelayanan tetap berjalan optimal saat terjadi gangguan sistem.

4) Pengendalian Risiko Gangguan E-Klaim BPJS

Gangguan e-klaim yang terjadi pada bulan Januari-Juni 2026 dapat dilihat pada grafik berikut.



Analisis:

Berdasarkan data kejadian gangguan E-Klaim periode Januari–Juni 2026, terdapat total 14 kejadian gangguan dengan pola kejadian yang mengalami peningkatan pada bulan Juni. Gangguan tercatat sebanyak 1 kejadian pada Januari, meningkat menjadi 3

kejadian pada Februari, tidak terdapat kejadian pada Maret dan April, kemudian kembali terjadi peningkatan menjadi 2 kejadian pada Mei dan 8 kejadian pada Juni.

Peningkatan signifikan pada bulan Juni menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap faktor penyebab gangguan, baik yang berasal dari sistem E-Klaim, koneksi/bridging dengan sistem terkait, jaringan, maupun faktor operasional pengguna. Gangguan E-Klaim berpotensi berdampak pada proses pengajuan klaim pelayanan pasien sehingga dapat memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian administrasi dan proses pembiayaan rumah sakit.

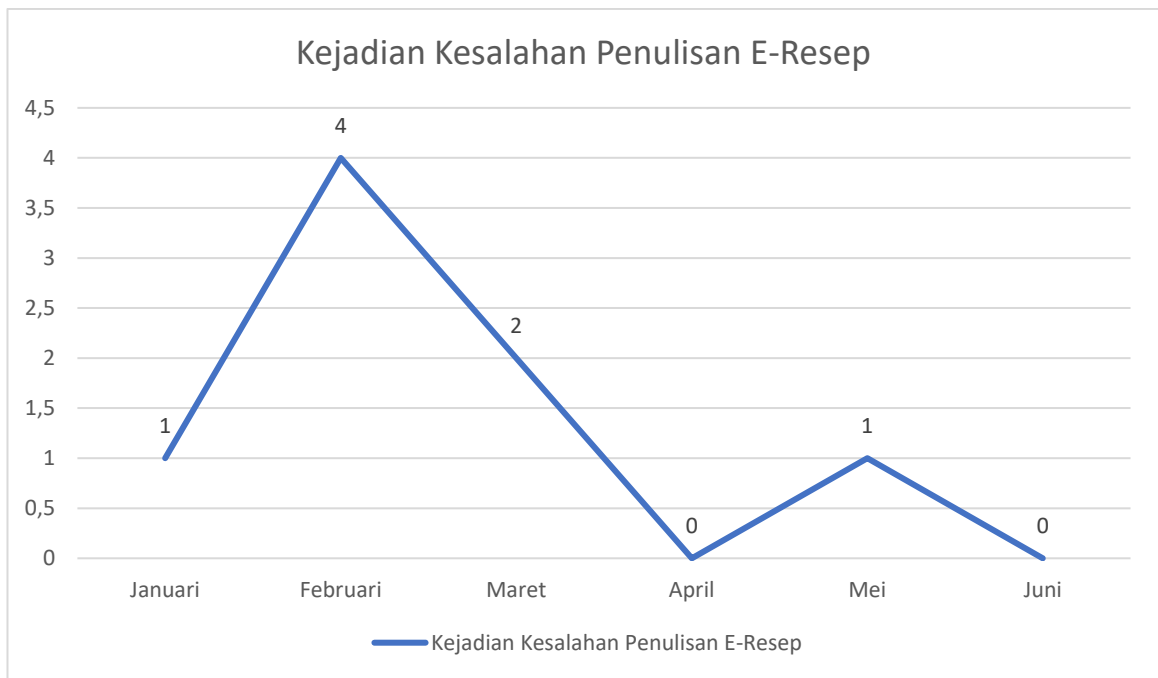
Tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi identifikasi akar masalah setiap kejadian gangguan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait (internal maupun eksternal), pemantauan stabilitas sistem, serta penguatan prosedur penanganan apabila terjadi gangguan agar proses pelayanan dan administrasi klaim tetap berjalan optimal.

Tabel PDSA

Problem	Terdapat 14 kejadian gangguan E-Klaim selama Januari–Juni 2026, dengan peningkatan kejadian signifikan pada bulan Juni sebanyak 8 kejadian. Gangguan E-Klaim berpotensi menghambat proses pengajuan klaim dan berdampak pada kelancaran administrasi pembiayaan rumah sakit.
Plan	Melakukan identifikasi penyebab gangguan E-Klaim melalui evaluasi setiap kejadian, melakukan koordinasi dengan unit terkait (Keuangan/Klaim, IT, dan pihak eksternal apabila diperlukan), melakukan pengecekan koneksi bridging dan stabilitas sistem, serta menyusun langkah pencegahan untuk mengurangi kejadian berulang.
Do	Melaksanakan pencatatan dan pelaporan setiap gangguan E-Klaim, melakukan troubleshooting saat terjadi gangguan, melakukan koordinasi perbaikan dengan pihak terkait, serta melakukan pemantauan terhadap kelancaran sistem setelah dilakukan perbaikan.
Study	Berdasarkan hasil monitoring, gangguan E-Klaim masih terjadi secara fluktuatif dengan peningkatan tertinggi pada bulan Juni. Evaluasi menunjukkan perlunya penguatan monitoring sistem dan komunikasi antar unit agar gangguan dapat segera teridentifikasi dan ditangani sehingga tidak menghambat proses klaim.
Action	Melakukan monitoring kejadian gangguan E-Klaim secara berkala, melakukan evaluasi akar masalah pada setiap kejadian, meningkatkan preventive maintenance dan pemantauan sistem bridging, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan evaluasi efektivitas perbaikan untuk mencegah kejadian berulang.

5) Peningkatan Keamanan Proses E-Resep

Kesalahan input e-resep yang terjadi pada bulan Januari-Juni dapat dilihat pada grafik berikut.



Analisis:

Berdasarkan data kejadian kesalahan input E-Resep periode Januari–Juni 2026, terdapat total 8 kejadian dengan pola kejadian yang mengalami fluktuasi setiap bulan. Kejadian tercatat sebanyak 1 kali pada bulan Januari, meningkat menjadi 4 kali pada Februari, kemudian menurun menjadi 2 kali pada Maret, tidak terdapat kejadian pada April, kembali terjadi 1 kali pada Mei, dan tidak terdapat kejadian pada Juni.

Peningkatan kejadian pada bulan Februari menjadi perhatian karena menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dalam proses input resep elektronik. Kesalahan input E-Resep dapat berisiko menyebabkan keterlambatan pelayanan obat maupun ketidaksesuaian informasi resep apabila tidak dilakukan verifikasi secara optimal. Penurunan hingga tidak ditemukannya kejadian pada bulan Juni menunjukkan adanya perbaikan dalam proses, namun tetap diperlukan upaya pencegahan agar kejadian tidak berulang.

Tindak lanjut dilakukan melalui evaluasi setiap kejadian, identifikasi faktor penyebab (human error, pemahaman penggunaan sistem, maupun proses verifikasi), penguatan kepatuhan terhadap prosedur input dan verifikasi resep, serta monitoring berkelanjutan terhadap kejadian kesalahan input E-Resep.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Manajemen Risiko ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan upaya pengelolaan risiko secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit. Melalui identifikasi, analisis, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap risiko yang ditemukan, diharapkan potensi kejadian yang dapat menghambat pelayanan dapat diminimalkan serta tercipta proses pelayanan yang lebih aman, efektif, dan berkesinambungan.

Malang, 07 Juli 2026

Penyusun,

Ketua Komite PMKP



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes